

NS

CARLOS ALBERTO ALVES CAIRO

IDADE: 64 PESO: 84 ALTURA: 180 PROFISSÃO: Engenheiro
 SINTOMAS: Ronco / Boca seca / gastrite / tosse seca / fentura.
 QUEIXAS:
 MEDICAMENTOS: Rogator
 Colutorol
 MÉDICO: Dr. Alexandre / Dr. Carlos Experição
 EXERCÍCIO FÍSICO: Natação / Musc. (3x)
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 19:30
 HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 7:30
 COCHILO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO esporádico
 FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: Nasal BANHEIRO: 1X
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: não CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 38
 OVERLAP: Brônquitos MALLAMPATI: IV IAH: 38,2 SPO2: 78%
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Dispositivos 27.3/er
 CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não
 COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA () CARDÍACA
 (N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS
 15/09 P= 4-12 N30i
 23 autom.

10/11/23 P= 6,0 cmH₂O

IAH= 6,1 e/h IA= 3,6 C: 3,6 IH= 2,5
 m. de uso: 7h13 10:40
 fuga: 28 l/min * não ainda por
 escape.

21/11 P= 6 cmH₂O

23 IAH= 6,1 e/h
 m. de uso: 7h34
 Fuga = 19,7 l/min.

melhora da tosse
 e causação,
 fentura
 fua

18/12 P= 6 cmH₂O

23 IAH= 6,1 (IA= 3,1 / IH= 3,0).
 m. de uso: 7h
 fuga = 20,4 percento.
 Troco o filtro - Biologix

fua

05/02 P= 6,0 cmH₂O

24 IAH= 6,6 e/h
 m. de uso: 6h30
 Fuga = 22,7.

Troco o Prong p/
 a com pino.

Relata que o desvio de septo está
 dificultando o uso. fua

04/03
24 P = 6 cmH₂O
IAH = 5.4 e/ev
M. de uso: 7h13'

Relata melhora da dispnéia
fue

01/04
24 P = 6 cmH₂O
IAH = 4.0 e/ev
M. de uso: 7h40'
Fuga

Relata que após a cirurgia
de desvio de septo, melhorou
p/ respirar.
fue

06/05
24 P = 6 cmH₂O
M. de uso: 7h
IAH = 5.2 e/ev
P ↑ α (IAH ↑) levemente

↑ P = 6.4
troco o filtro
então ↓ 5.8 cmH₂O

Bem adapt.

fue

10/06
24 P = 6 cmH₂O
IAH = 5.3 e/ev
M. de uso: 7h3'
Fuga = 4.1

fue

09/12
2024 P = 6 cmH₂O
IAH = 3.4 e/ev
M. de uso: 7h00
fuga = 24 e/min

Bem adapt; tem 2 máx } Pico → veloz num
relata após cirurgia } n30i → está usando
desvio septo tem máx remanece } agora
siu

10/03
2024 P = 6 cmH₂O
IAH = 2.3 e/ev
M. de uso: 7h06 min
fuga = 14 e/min

troco filtro

siu

02/05
25 P = 6 cmH₂O
IAH = 2.2 e/ev
M. de uso: 6h28'
Fuga = 11.2 e/ev

relata boca seca.

fue cláudia

23/06
25 P = 9.2 cmH₂O
IAH = 3.9 e/ev
M. de uso: 36.2
fuga = 36.2 e/ev

Bem adapt.
Troco a máx.

fue

CPF: 000
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 62858

PSIQUIATRIA

CRM-SP 69730

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Carlos Alberto Alves Cairo

EXAME nº: 5437

SOLICITADO POR: Dr. Alexandre Coelho Marques

DATA: 18/07/2023

IDADE: 64 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h21min e concluído às 06h04min. A latência para o sono foi de 12 minutos e a latência para o estágio REM, de 123 minutos. O tempo total de sono foi de 369,5 minutos (06h09min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 79,6%. A distribuição do sono mostrou 21,5% de estágio 1, 50,7% de estágio 2, 8,9% de estágio 3 e 18,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 82 minutos em vigília, ocorreram 168 microdespertares (índice: 27,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 38,2/hora, sendo 3,7 apneia/hora e 34,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 49,8/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (38,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (49,8/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 12 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (123 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 79,6%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 27,3/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (21,5%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 3 (8,9%; normal: 10-12%) e REM (18,8%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (50,7%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 16 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730